DR. JOSEHP CHRISTOPHER CASTILLO CUENCA
MÉDICO ANATOMOPATÓLOGO | C.M.P. 56435 R.N.E. 029091
Email: grupopatologia2012@gmail.com | Cel: 986396733

| | | |
|---|---|---|
| **APELLIDOS Y NOMBRES :** NELLI, CANAYO SILVANO | | **26Q-224** |
| **EDAD :** 37 AÑOS | **SEXO :** FEMENINO | |
| **FECHA DE RECEPCIÓN :** 03/08/2026 | **FECHA DE INFORME :** 07/08/2026 | |
| **INDICACIÓN:** DR. JORGE ALBERTO MUÑANTE ARZAPALO | | |

## DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Se recibe vesícula biliar de configuración elongada, que mide 7.5 x 4.0 x 3.5 cm, con superficie serosa de aspecto granular y congestiva, presentando áreas de fibrinopurulencia adheridas. Al corte transversal, la pared muestra un marcado engrosamiento difuso (hasta 1.2 cm de espesor), con consistencia firme y aspecto blanquecino-grisáceo, sugerente de fibrosis transmural. La luz se encuentra distendida y contiene material biliar turbio, espeso y de coloración verdoso-oscura. La mucosa presenta pérdida de su patrón reticular habitual, con áreas de ulceración focal y depósitos de material calcáreo granular adheridos a la pared.

## DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:

Los cortes histológicos revelan una pared vesicular con arquitectura distorsionada por un denso infiltrado inflamatorio crónico, predominante linfoplasmocitario y con agregados linfoides foliculares, que se extiende desde la submucosa hasta la capa muscular y serosa. Este proceso se superpone con un componente agudo exudativo, caracterizado por abundante infiltrado neutrofílico intraparietal, microabscesos en la mucosa y ulceración del epitelio superficial con exudado fibrinopurulento en la luz. Se observa fibrosis hialina extensa que disocia las fibras musculares lisas, así como numerosos senos de rokitansky-aschoff dilatados, algunos de ellos rellenos de barro biliar e infiltrados por histiocitos espumosos. El epitelio de revestimiento remanente muestra metaplasia escamosa focal y cambios regenerativos atípicos reactivos, sin evidencia de displasia franca ni invasión estromal. No se identifican células neoplásicas ni depósitos amiloides.

## DIAGNÓSTICO HISTOLOGICO:

**VESICULA BILIAR**

**VESÍCULA BILIAR CON COLECISTITIS CRÓNICA REAGUDIZADA, CON EXTENSA FIBROSIS MURAL, ULCERACIÓN MUCOSA Y ABSCESOS INTRAMURALES, SIN EVIDENCIA DE NEOPLASIA INTRAEPITELIAL NI CARCINOMA INFILTRANTE.**

Josehp C. Castillo
JOSEHP C. CASTILLO CUENCA
MÉDICO ANATOMO PATÓLOGO
C.M.P. 56435 R.N.E. 029091

JOSEHP CHRISTOPHER CASTILLO CUENCA MÉDICO ANATOMOPATÓLOGO C.M.P. 56435 R.N.E. 029091